

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

NEUSA ALVES GARCIA BEZERRA

IDADE:	PESO: 70	ALTURA:	PROFISSÃO: Cabeleleira
SINTOMAS:	Panco; Sono linear diurna; Acorda cansada.		
QUEIXAS:	refluxo; tinite; tosse seca.		
MEDICAMENTOS:	puxon (hipotensivo); Glifage; Losartana; Anacetatina.		
MÉDICO:	Dr André Costa - Otorino. / Dra Laura (gastro)		
EXERCÍCIO FÍSICO:	Academia 2x; Hidroginástica 2x.		
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:
HORA QUE DORME: 00h / 01h	HORA QUE ACORDA: 8h.		
COCHILHO (X) SIM () NÃO	DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL		
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO	↳ marido dorme outro quarto		
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	há 30 anos		
TIPO DE RESPIRAÇÃO:	BANHEIRO: 3x		
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:		
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH: 13,9 elh	SPO2: 72%.
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Desvio Septo			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS -			
22/01/2024 Análise Auto 4 a 10 cm H ₂ O Pico 3 dias			
Máx Pico S/M			
25/01 24	P= 8.0 IAH= 1.4 m. de uso: 6h37'	Relata que no 2º d., teve dor de cabeça / fúria vindo q' ansiedade p' dormir, 1 hora.	
09/02 2024	P= 8 cm H ₂ O IAH= 1,4 elh m. uso= 7h13 min fuga= 2,8 el/min.	- Acorda mais disposta - Bem adaptada	
04/03 24	P= 8 cm H ₂ O IAH= 1,3 m. de uso: 6h57 fuga: 0,5 el/min	- Bem adaptada - ajuste em medicações Natacha	
03/04/24	P= 8 cm H ₂ O IAH= 1,5 elh m. de uso: 6h54m fuga: 1,3 el/min	Bem adaptada Natacha	

03/06 P= 8cmH₂O

Bem adaptada, s/ queixas.

24 M. de uso: 6h33'
IAH= 1.1 el/h
Fuga= 1.2 lpm.

fua.

04/09 P= 8cmH₂O

24 IAH= 0.8
m. de uso: 6h34'
Fuga= ~~0.3~~ 0.3 lpm.

Bem adapt. — fua

06/12

2024 P= 8cmH₂O

refere sonolência diurna / está despertando mais à noite

IAH= 4.1 el/h

m. de uso: 6h20min

fuga 0.

↓ P: 7,6 cmH₂O

Arco filtro.

Silênc

30/03/25 P= 7,6cmH₂O

IAH= 1,0 el/h

m. de uso: 6h50min

fuga= 0,4 l/min

- queixa

sonolência após Almoço.

- melhora dos despertares

72kg.

2x exerc. hidroq. 10hrs

2x " quástica

Silênc

03/06/25 P= 7,6cmH₂O

IAH= 1,0 el/h

m. de uso: 5h53'

fuga: 0,3 l/min

- queixa de tontura e náusea

Oriento usar água destilada

Natacha

Nome: NEUSA ALVES GARCIA BEZERRA
Data de Nascimento: 9-7-1961
IMC: 30,76
Sexo: Feminino
Data do exame: 22-02-2023

Peso: 72 kg
Altura: 1,53 m
Médico: DRA. KARINA FERNANDA
REMONDINI FROES
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-02-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 488,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 126,5 e 131,0 minutos. O tempo total de sono foi de 324,0 min, eficiência de 66,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 56,9%; estágio N3: 18,5%; sono REM: 21,9%. O índice de despertares foi de 5,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 13,9/hora, sendo 46 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 72%, permanecendo 2,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 73 bpm e NREM de 49 - 73 bpm.

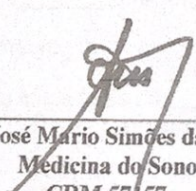
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 13,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=72%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau leve. Presença de bruxismo.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57